



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE 3278-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0147-2026/CC1

DENUNCIANTES : JUDITH PILAR GUERRA HUAMANÍ (SEÑORA GUERRA)
: **GYH LEGAL E.I.R.L. (GYH LEGAL)**
DENUNCIADO : CLÍNICA INTERNACIONAL S. A. (CLÍNICA)
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA
DECLINACIÓN DE COMPETENCIA
ACTIVIDAD : ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA

Lima, 16 de enero de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 11 de noviembre de 2025, la señora Guerra y GYH Legal denunciaron a la Clínica, por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor¹ (en adelante, el Código), señalando lo siguiente:
 - (i) El 10 de octubre de 2025, la señora Guerra solicitó a la Clínica el presupuesto de una intervención quirúrgica y la gestión para la aprobación de una carta fianza y se le informó que la cirugía laparoscópica contaba con una cobertura del 70% del costo total, mientras que el uso de un robot en una cirugía laparoscópica tendría que ser asumido íntegramente en su calidad de paciente.
 - (ii) El 11 de octubre de 2025, la Clínica informó que el presupuesto aprobado ascendía a S/ 25 474,13, detallando un copago de S/ 7 642,23 por la cirugía laparoscópica y un deducible de S/ 1 226,00 por un día de hospitalización; en la misma comunicación, indicó que la técnica robótica tenía un costo adicional de S/ 3 644,28, aplicable si se optaba por la cirugía laparoscópica robótica, sin informar la existencia de otros costos distintos a los gastos no cubiertos.
 - (iii) Asimismo, ante consultas expresas sobre posibles gastos adicionales, la Clínica solo mencionó los referidos gastos no cubiertos, sin señalar que el uso del robot implicara un monto distinto o superior al presupuesto adicional informado, por lo que se indicó que el monto aproximado a asumir sería de S/ 12 512,52, el cual fue aceptado y pagado por la señora Guerra en calidad de titular de GYH Legal.
 - (iv) El 25 de octubre de 2025, se realizó la intervención quirúrgica laparoscópica robótica en la Clínica y se efectuó un pago adicional de S/ 129,61 conforme a la preliquidación emitida por la Clínica, abonando un total hasta ese momento a S/ 12 642,13.
 - (v) El 26 de octubre de 2025, se otorgó el alta médica sin que se entregue la liquidación total correspondiente a la intervención quirúrgica.

¹ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano y vigente desde el 2 de octubre del 2010.



- (vi) El 6 de noviembre de 2025, la Clínica informó que el costo total por el uso de la técnica robótica ascendía a S/ 7 184,61, monto distinto y superior al previamente informado de S/ 3 644,28. Con la finalidad de evitar la ejecución de una letra de cambio suscrita en blanco, se efectuó el pago del monto pendiente ascendente a S/ 2 323,76; sin embargo, la Clínica no entregó boleta ni factura por dicho monto.
2. La señora Guerra y GYH Legal solicitaron, en calidad de medida correctiva, que la Clínica cumpla con: (i) realizar el reembolso por el pago excedente por el uso del robot, esto es, por el monto de S/ 3 540,33, más los intereses de legales respectivos; y, (ii) enviar la factura o boleta respectiva por el monto pagado por S/ 2 323,76. Asimismo, requirió el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.

ANÁLISIS

Sobre la improcedencia de la denuncia interpuesta por la señora Guerra y GYH Legal

3. El artículo 105° del Código establece que el Indecopi es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas, conforme a la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo 1033. Asimismo, en la referida norma se señala que dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.²
4. Dicho criterio fue recogido previamente en el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Defensa de la Competencia mediante Resolución 0277-1999/TDC-INDECOPI³, que señaló lo siguiente:
- “Por excepción establecida en norma expresa de rango legal, únicamente pueden entenderse aquellas disposiciones contenidas en las leyes, u otras normas de igual jerarquía, que señalen que una entidad administrativa, distinta a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, será competente para sancionar presuntas infracciones (a la Ley de Protección al Consumidor) que puedan cometerse en las relaciones de consumo que se presenten en un sector específico”.*
5. Al respecto, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, la Comisión) debe verificar si el Indecopi es el órgano competente para pronunciarse sobre el hecho cuestionado por la señora Guerra y GYH Legal en su denuncia.

² **LEY 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**
Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente capítulo, conforme al Decreto legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.
(...)

³ Ver Resolución 277-1999/TDC-INDECOPI del 18 de agosto de 1999, seguido por Shirley Sánchez Cama contra José Cantuarias Pacheco y Corporación José R. Lindley S.A.



(i) **De la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud)**

6. El Decreto Legislativo 1158, cuerpo normativo orientado al fortalecimiento de Susalud, tiene como objetivo⁴ promover, proteger y defender los derechos de quienes accedan a los servicios de salud, garantizando que estos sean de calidad, estableciendo bajo su ámbito de competencia a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).⁵
7. Los artículos 6 y 7 del referido cuerpo normativo precisan que las IAFAS comprenden, entre otras entidades, a las compañías aseguradoras, las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) y Asociaciones de Fondos Regionales y Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT), mientras que las IPRESS se encuentran comprendidas por establecimientos de salud, servicios de apoyo médico y servicios complementarios o auxiliares de atención médica.⁶

⁴ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD**, aprobada por **DECRETO LEGISLATIVO 1158** y publicado 6 de diciembre de 2013

Artículo 1.- Objeto de la norma

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto disponer las medidas destinadas al fortalecimiento de las funciones que actualmente desarrolla la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, con la finalidad de promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quien la financie.

⁵ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD**, aprobada por **DECRETO LEGISLATIVO 1158** y publicado 6 de diciembre de 2013

Artículo 5.- Ámbito de competencia

La Superintendencia Nacional de Salud es una entidad desconcentrada y sus competencias son de alcance nacional. Se encuentran bajo el ámbito de competencia de la Superintendencia todas las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), así como todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS). Asimismo, se encuentran bajo el ámbito de competencia de la Superintendencia las Unidades de Gestión de IPRESS, definidas como aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, diferentes de las IPRESS, encargadas de la administración y gestión de los recursos destinados al funcionamiento idóneo de las IPRESS. (...)

⁶ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD**, aprobada por **DECRETO LEGISLATIVO 1158** y publicado 6 de diciembre de 2013

Artículo 6.- De las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS

Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) son aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, que reciban, capten y/o gestionen fondos para la cobertura de las atenciones de salud o que oferten cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad. El registro en la Superintendencia Nacional de Salud es requisito indispensable para la oferta de las coberturas antes señaladas.

Son IAFAS las siguientes:

1. Seguro Integral de Salud.
2. Seguro Social de Salud (EsSalud), excluyendo la cobertura de prestaciones económicas y sociales.
3. Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).
4. Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
5. Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
6. Empresas de Seguros contempladas en los numerales 1, 2 y 3 del inciso d) del artículo 16° de la Ley 26702, que oferten cobertura de riesgos de salud de modo exclusivo o en adición a otro tipo de coberturas.
7. Asociaciones de Fondos Regionales y Provinciales Contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT).
8. Entidades de Salud que ofrecen servicios de salud prepagadas.
9. Autoseguros y fondos de salud, que gestionen fondos para la cobertura de salud de modo exclusivo o en adición a otro tipo de coberturas.
10. Otras modalidades de aseguramiento público, privado o mixto distintas a las señaladas anteriormente.



8. De la lectura conjunta de los referidos dispositivos legales, se desprende que Susalud es una entidad que tiene como finalidad la protección de los intereses de las personas que accedan a servicios de salud, lográndose dicho objetivo a través de la supervisión de las IAFAS e IPRESS.
9. A fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones y objetivos, Susalud cuenta con potestad sancionadora para reprimir aquellas conductas que afecten: (i) el derecho a la vida, salud e información de los usuarios de servicios de salud y la cobertura para su aseguramiento; y, (ii) los estándares de acceso, calidad, oportunidad y disponibilidad con los que dichas prestaciones serán otorgadas.⁷
10. Dichas conductas, conforme al artículo 11 del citado dispositivo legal, acarrearán la imposición de sanciones que abarcan desde una amonestación escrita hasta la revocación de la autorización de funcionamiento para las IAFAS e IPRESS⁸.
11. Asimismo, conforme al Anexo I-C del Reglamento de Infracciones y Sanciones de Susalud, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2014-SA, dicha entidad se encuentra facultada para sancionar, entre otras conductas, el hecho consistente en modificar o contravenir el clausulado mínimo de los contratos o convenios suscritos con una IAFAS⁹.

Artículo 7.-De las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) son aquellos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de la salud. En adición al cumplimiento de las normas de carácter general del Ministerio de Salud, para brindar servicios de salud deberán encontrarse registradas en la Superintendencia Nacional de Salud.

- ⁷ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO 1158 y publicado 6 de diciembre de 2013**

Artículo 10.- Potestad sancionadora de la Superintendencia

Para el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 8 y 9 del presente Decreto Legislativo, la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con potestad sancionadora sobre toda acción u omisión que afecte: i) el derecho a la vida, la salud, la información de las personas usuarias de los servicios de salud y la cobertura para su aseguramiento, y; ii) los estándares de acceso, calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad con que dichas prestaciones sean otorgadas. (...)

- ⁸ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO 1158 y publicado 6 de diciembre de 2013**

Artículo 11.- Tipos de Sanciones

La Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida, puede imponer a las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS, vinculadas al Sistema Nacional de Salud, los siguientes tipos de sanción:

- a. Amonestación escrita;
 - b. Multa hasta un monto máximo de quinientas (500) UIT;
 - c. Suspensión de la Autorización de Funcionamiento para IAFAS, hasta por un plazo máximo de seis (6) meses, cuyo efecto consiste en el impedimento para realizar nuevas afiliaciones;
 - d. Restricción de uno o más servicios de IPRESS, hasta por un plazo máximo de seis (6) meses;
 - e. Cierre temporal para IPRESS, hasta por un plazo máximo de seis (6) meses;
 - f. Revocación de la Autorización de Funcionamiento para IAFAS;
 - g. Cierre definitivo para IPRESS.
- (...)

- ⁹ **ANEXO III - INFRACCIONES APLICABLES A LAS IPRESS**



12. Adicionalmente a su potestad sancionadora, Susalud se encuentra facultada a ordenar medidas correctivas, a fin de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente.¹⁰
13. En efecto, dichas medidas correctivas consistirán, por ejemplo, en la devolución de los cobros indebidos realizados por quienes incurrieron en la conducta infractora, la atención a la solicitud de información requerida por el asegurado, la declaración de inexigibilidad de las cláusulas de sus contratos que resulten abusivas y/o la publicación de avisos rectificatorios o informativos, así como las medidas correctivas que dispone el Código y que resultan aplicables a su ámbito de competencia¹¹.
14. Además, Susalud tiene la potestad de aplicar multas coercitivas en el supuesto que los infractores sancionados sean renuentes al cumplimiento de la sanción impuesta, las medidas correctivas ordenadas y/o en caso incurran nuevamente en la conducta infractora¹².

ANEXO III – A INFRACCIONES DE CARACTER GENERAL INFRACCIONES LEVES

(...)

26. Modificar o contravenir el clausulado mínimo de los contratos o convenios suscritos con una IAFAS.

(...)

- 10 **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO 1158 y publicado 6 de diciembre de 2013**

Artículo 10.- Potestad sancionadora de la Superintendencia

(...)

Sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su competencia imponga la Superintendencia Nacional de Salud, podrá ordenar la implementación de una o más medidas correctivas, con el objetivo de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente.

(...)

- 11 **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO 1158 y publicado 6 de diciembre de 2013**

Artículo 14.- Medidas correctivas

Las medidas correctivas se dictan conjuntamente con la resolución que impone la sanción, y tienen por finalidad corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, la Superintendencia podrá ordenar la implementación de una o más de las siguientes medidas correctivas:

1. Devolver los cobros indebidos o en exceso, según la cobertura de los planes de salud correspondientes.
2. Cumplir con atender la solicitud de información requerida por el asegurado, siempre que dicho requerimiento guarde relación con su cobertura de salud y/o afecte el ejercicio de sus derechos;
3. Declarar inexigibles las cláusulas de sus contratos o convenios que han sido identificadas como abusivas;
4. Publicar avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine la Superintendencia Nacional de Salud tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto materia de sanción hubiere ocasionado;
5. Someter a la IAFAS al Régimen de Vigilancia, entendido como el proceso de supervisión continua a la IAFAS previa presentación de su Plan de Recuperación, el cual será aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud.

(..)

- 12 **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO 1158 y publicado 6 de diciembre de 2013**

Artículo 15.- Multas coercitivas

Si los infractores sancionados son renuentes al cumplimiento de la sanción, o de las medidas correctivas ordenadas, dentro del plazo otorgado, se les impondrá una multa coercitiva no menor de tres (3) UIT. Si el administrado persistiese en el incumplimiento, se podrá imponer una nueva multa coercitiva, la cual podrá ser reiterada en forma trimestral,



15. Por otro lado, el 13 de agosto de 2015, se publicó el Reglamento del Procedimiento de Transferencia de Funciones del Indecopi a Susalud, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2015-SA (en adelante, Reglamento de Transferencia de Funciones), el cual establece que esta última entidad es la autoridad competente para promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, así como para conocer, con competencia primaria y alcance nacional, las presuntas infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de consumo con la IPRESS y/o IAFAS.¹³
16. Ahora bien, respecto de la competencia de Susalud y del Indecopi, el artículo 9 del citado Reglamento¹⁴ dispone lo siguiente:
- (i) **Susalud asume competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos a partir de la vigencia de la norma (14 de agosto de 2015)**, que constituyan presuntas infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de consumo con las instituciones bajo su ámbito de competencia, así como aquellas previas o derivadas de esta.

duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta, hasta el límite de cincuenta (50) UIT. La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notificada.

13

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUSALUD EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1158, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 026-2015-SA y publicado el 13 de agosto de 2015
Artículo 5.- Competencias Generales de la Superintendencia Nacional de Salud

- 5.1. SUSALUD es la autoridad competente para promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quien las financie, así como los que correspondan en su relación de consumo con las IAFAS e IPRESS, incluyendo aquellas previas y derivadas de dicha relación; así como para conocer con competencia primaria y alcance nacional, las presuntas infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de consumo con la IPRESS y/o IAFAS.
- 5.2. SUSALUD es competente también para identificar las cláusulas abusivas en los contratos o convenios que suscriben las IAFAS con los asegurados o entidades que los representen, según las disposiciones aplicables de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, con excepción de las pólizas de seguros de las Empresas de Seguros bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de la protección al consumidor o usuario directamente afectado respecto de la aplicación de la referida cláusula en el caso en concreto.
- 5.3. SUSALUD velará por el cumplimiento de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y sus normas complementarias y conexas, en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud, por la falta de idoneidad de los servicios ofrecidos por las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, ejerciendo su potestad sancionadora en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1158.

14

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUSALUD EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1158, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 026-2015-SA y publicado el 13 de agosto de 2015
Artículo 9.- Procedimientos asumidos por SUSALUD

SUSALUD asume competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos a partir de la vigencia de la presente norma, que constituyan presuntas infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de consumo con las instituciones bajo su ámbito de competencia, así como aquellas previas o derivadas de ésta.

INDECOPI mantiene competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos antes de la vigencia de la presente norma, en las materias señaladas en el párrafo precedente, hasta su conclusión en la vía administrativa, arbitral y/o sede judicial.



- (ii) **Indecopi mantiene competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos antes de la vigencia de la norma (hasta el 13 de agosto de 2015)**, en las materias señaladas en el párrafo precedente, hasta su conclusión en la vía administrativa, arbitral y/o sede judicial.

17. Por su parte, el Reglamento para la Atención de Reclamos y Quejas de los Usuarios de las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2016-SA y publicado el 27 de julio de 2016, establece que Susalud es la autoridad competente para conocer y resolver los procedimientos para la atención de reclamos y quejas de usuarios establecidos por dicha entidad¹⁵.
18. A continuación, se determinará la autoridad competente para conocer la denuncia interpuesta por la señora Guerra y GYH Legal contra la Clínica, de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes.

(ii) **Aplicación al caso concreto**

19. El numeral 5.3 del artículo 5 del Reglamento del Procedimiento de Transferencia de Funciones establece que Susalud es la entidad encargada de velar por el cumplimiento del Código, así como sus normas complementarias y conexas en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud.¹⁶

¹⁵ **REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS DE LOS USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD – IAFAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD – IPRESS Y UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD – UGIPRESS, PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS**, aprobado por DECRETO SUPREMO 030-2016-SA y publicado el 27 de julio de 2016

Artículo 1.- Del objeto

- 1.1. Establecer el procedimiento para la atención de las quejas y reclamos presentados por los usuarios o terceros legitimados ante la insatisfacción respecto de los servicios, prestaciones o coberturas solicitadas a, o recibidas de, las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPRESS, o que dependan de las Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas.

(...).

Artículo 4.- Del ámbito de aplicación

- 4.1. El presente Reglamento es aplicable a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas a nivel nacional; a los usuarios o terceros legitimados en su relación con dichas instituciones, así como a SUSALUD.

(...).

Artículo 6.- De las instancias competentes

(...)

- 6.2. SUSALUD a través de IPROT o las Intendencias Macro Regionales de SUSALUD en caso de encargo de funciones, son competentes para la recepción, procesamiento, atención y absolución de las consultas, peticiones de intervención y quejas presentadas por los usuarios o terceros legitimados.

(...).

Artículo 12.- De la canalización de reclamos

Los reclamos presentados a las IAFAS, IPRESS O UGIPRESS por cualquier medio deberán ser canalizados por éstas al Libro de Reclamaciones en Salud Virtual o Físico, según corresponda.

¹⁶ **REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUSALUD EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1158, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 026-2015-SA Y PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DE 2015**

Artículo 5.- Competencias Generales de la Superintendencia Nacional de Salud

(...)



20. De lo expuesto se desprende que Susalud es la entidad competente para supervisar el cumplimiento de las normas que protegen a los consumidores de la falta de idoneidad respecto de las prestaciones de salud, así como el derecho de los consumidores a acceder a información vinculada a dichas prestaciones.
21. En el presente caso, la señora Guerra y GYH Legal cuestionaron que la Clínica: (i) habría cobrado indebidamente un monto excedente a las denunciadas, en la medida que informó inicialmente un monto de S/ 3 644,28 por el uso de la técnica robótica en la intervención quirúrgica laparoscópica robótica realizada el 25 de octubre de 2025, pese a que posteriormente cobró la suma de S/ 7 184,61 por el referido concepto de intervención médica; y, (ii) no habría cumplido con entregar el comprobante de pago correspondiente al monto de S/ 2 323,76 abonado con posterioridad a la intervención quirúrgica laparoscópica robótica.
22. En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Guerra y GYH Legal contra la Clínica, en la medida que las conductas cuestionadas por las denunciadas resultan ser materia de competencia de Susalud.
23. Adicionalmente, este órgano colegiado estima pertinente remitir a Susalud el original de todo lo actuado en el presente procedimiento, a efectos de que adopte las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia.

RESUELVE

PRIMERO: declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Judith Pilar Guerra Huamaní y GYH Legal E.I.R.L. contra la Clínica Internacional S.A., por presunta infracción a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que las conductas cuestionadas resultan ser materia de exclusiva competencia de la Superintendencia Nacional de Salud. En consecuencia, disponer la devolución a la parte denunciante de la tasa por derecho de trámite pagada¹⁷, previa solicitud a la Unidad de Finanzas y Contabilidad del Indecopi.

SEGUNDO: ordenar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 que remita el original de todo lo actuado en el presente procedimiento a la Superintendencia

5.3. SUSALUD velará por el cumplimiento de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y sus normas complementarias y conexas, en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud, por la falta de idoneidad de los servicios ofrecidos por las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, ejerciendo su potestad sancionadora en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1158.

¹⁷ **Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva única que regula los procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección al Consumidor**

Artículo 13.- Improcedencia de la denuncia

13.1 En los supuestos en que el órgano resolutorio determine que los hechos materia de denuncia deben ser conocidos por una Junta Arbitral de Consumo o Centro de Arbitraje, o un órgano regulador o supervisor distinto al INDECOPI, la resolución que declara la improcedencia de la denuncia dispone la remisión de los actuados a la entidad que corresponda y la devolución de la tasa pagada por el denunciante.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE 3278-2025/CC1

Nacional de Salud, a efectos de que adopte las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia.

TERCERO: informar a la señora Judith Pilar Guerra Huamaní y a GYH Legal E.I.R.L. que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación¹⁸, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación¹⁹, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida²⁰.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

¹⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

¹⁹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

²⁰ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.